

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22231697068 / 402

ADILSON SAMPAIO MAYLLART

IDADE: 82a PESO: 73 ALTURA: 167 PROFISSÃO: Economista - Apos.
SINTOMAS: Indisposto / memória ↓ /
QUEIXAS: Dorco / cansaço / acorda cansado / mau humor.
MEDICAMENTOS: fannumet + R / AAS / Artroliv / Clonazepam / Aroquel
DM / Quetiapina
MÉDICO: Dr. Dalinas / Dr. Mário Jorge / Dr. Orlando Hard.
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: 2x pilates / exerc. em casa.
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: —
HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 6:30
COCHILLO ☒ SIM () NÃO *as vezes* DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () X NA SEMANA () NÃO *vinho branco (1 taça)*
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 22 anos
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO:
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *flácida* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 39 cm H₂O
OVERLAP: Não MALLAMPATI: IV IAH: 84.3 e/ev SPO2: 75%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *Artrose mmss* FA = 28.7 e/ev / SS.6 hipox.
CIRURGIAS: (N) NASAL (M) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não IMC:
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA ☒ ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS *Aduna 4/55 (cirurgia)*
25/09 Avaliação max wisp tecido
24 P = 4-8 cm H₂O início

02/10 P = 7.6 cm H₂O Relata melhora
24 IAH = 2.4 e/ev da dispnéia
M. de uso: 7h

16/10 P = 7.8 cm H₂O Bem adaptada
24 IAH = 3.1 e/ev
M. de uso: 7h 15' Notícia

18/10/24 Ret. retorna p/ ver outra máscara pois a relata
que o wisp tecido é difícil de colocar
Comprou a dreamwear pillow

31/10 P = 7.8 med / perc. 8.9 / durante a manhã
24 IAH = 2.8 e/ev fizei a pressão 7.8
M. de uso: 6h 14' que

02/12 P = 7.8 cm H₂O
24 IAH = 0.5 e/ev
M. de uso: 6h 54' que

15/01/2025

$P = 7,8 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 0,4 \text{ e/h}$

m de uso: 6h 26'

fuga: 34,6 l/m

Relata ^{acordou} ~~acordou~~
causada.

Natasha

12/03/25

$P = 7,8 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 0,6 \text{ e/h}$

m de uso: 6h 46'

fuga: 30,8 l/m

Bem adaptado

para manter relato
de acordar causada

Natasha

14/05/25

$P = 7,8 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 0,2 \text{ e/h}$

m de uso: 7h 3'

fuga: 46 l/m

Relata estar cl

Tontura, Ana
orientou procurar
neuro

Natasha

25/06/25

$P = 7,4 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 0,3 \text{ e/h}$

m de uso: 7h 8'

fuga: 43,8 l/m

Bem adaptado

Oriento procurar fono.

Natasha

Clinica
DR. ALBERTO REMESAR
Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Adilson Sampaio Mayllart
EXAME nº: 5598
SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge
DATA 18/04/2024
IDADE: 82 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h11min e concluído às 06h01min. A latência para o sono foi de 2 minutos e a latência para o estágio REM, de 254 minutos. O tempo total de sono foi de 441,5 minutos (07h21min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 95,5%. A distribuição do sono mostrou 26,5% de estágio 1, 64,3% de estágio 2, 0,5% de estágio 3 e 8,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 19 minutos em vigília, ocorreram 164 microdespertares (índice: 22,3hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 84,3/hora, sendo 28,7 apneia/hora e 55,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 84,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 91%, sendo a saturação média de 88% e a mínima de 75%.

(*) TTS $\Leftarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Leftarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (84,3/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (84,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 81; máxima: 91 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 2 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (254 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência adequada (95,5%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 22,3/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (26,5%; normal: 8-10%) e 2 (64,3%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (0,5%; normal: 10-12%) e REM (8,7%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 8 (normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730